URGÊNCIA CLÍNICA · PROTOCOLO EDUCACIONAL

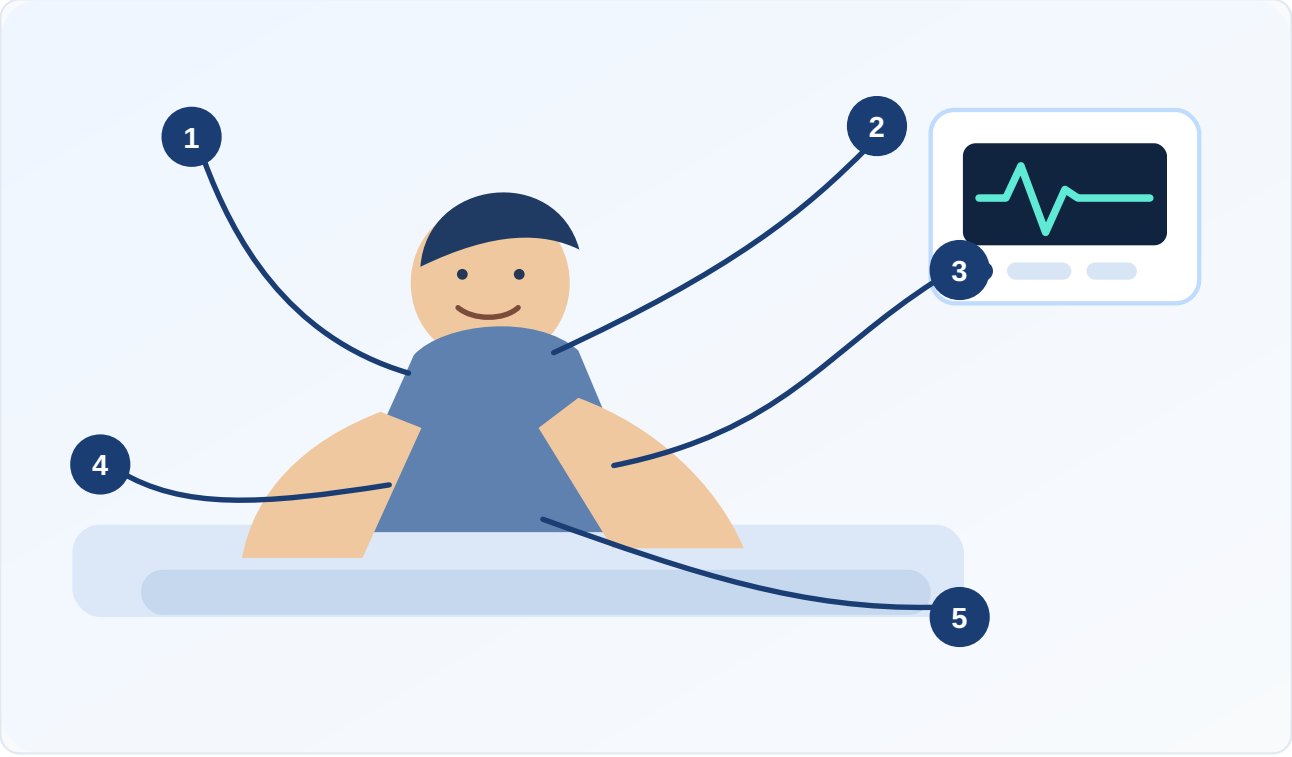
Sepse na emergência: reconhecimento, primeiras horas e reavaliação

Conteúdo aprofundado para organizar o raciocínio de enfermagem sem reduzir sepse a um checklist rígido de 60 minutos.

Revisado 03 out. 2026 **Base** SSC 2026 · Sepsis-3 **Nível** Graduação

Introdução

Sepse é uma emergência tempo-dependente, mas o cuidado atual não cabe em uma lista rígida de tarefas encerrada em 60 minutos. O objetivo desta página é organizar o raciocínio de enfermagem em torno de **reconhecimento precoce, tratamento oportuno, ressuscitação hemodinâmica e reavaliação contínua**.



Reconhecimento de deterioração: a ilustração organiza cinco áreas de observação. Os números são explicados ao lado; a imagem não substitui avaliação clínica.

O que observar primeiro

1. **Consciência:** alteração aguda do sensório ou queda do nível de resposta.
2. **Respiração:** taquipneia, esforço, hipoxemia ou aumento da necessidade de O_2.

3. **Circulação:** hipotensão, tendência de queda da pressão ou necessidade crescente de suporte.
4. **Perfusão:** enchimento capilar prolongado, pele fria/moteada e outros sinais de hipoperfusão.
5. **Diurese:** redução importante pode sinalizar disfunção orgânica.

ℹ **Escopo:** conteúdo educacional. Antimicrobianos, fluidos, vasopressores, exames e procedimentos dependem de avaliação clínica, prescrição/protocolo institucional e atribuições profissionais aplicáveis.

Base principal: **SSC 2026** · **Sepsis-3** .

1. O que é sepse

A definição Sepsis-3 descreve sepse como **disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção**. Na operacionalização do consenso, um aumento agudo de **2 ou mais pontos no SOFA** relacionado à infecção representa disfunção orgânica. Febre, leucocitose ou taquicardia isoladas não definem sepse; da mesma forma, ausência de febre não exclui um quadro grave.

Infecção

Suspeita ou confirmação de infecção sem evidência de disfunção orgânica aguda atribuível ao processo.

Sepse

Infecção associada a disfunção orgânica ameaçadora à vida; exige avaliação e tratamento urgentes.

Choque séptico

Subgrupo de maior gravidade, com anormalidades circulatórias/metabólicas e necessidade de suporte hemodinâmico.

Não espere a definição completa de choque séptico para começar a tratar um paciente instável. A classificação ajuda a comunicar gravidade; a ressuscitação deve começar quando a avaliação clínica indica emergência.

Definições: **Sepsis-3** .

2. Reconhecimento e triagem

O reconhecimento começa antes do diagnóstico definitivo. Na emergência, combine **suspeita de infecção + tendência clínica + sinais de disfunção orgânica**. Uma mudança em relação ao basal pode ser mais informativa do que um valor isolado.

TRIAGEM HOSPITALAR

NEWS / NEWS2

Integra vários sinais fisiológicos e é recomendado pela SSC 2026 como opção de rastreio em pacientes agudamente enfermos.

TRIAGEM HOSPITALAR

MEWS ou SIRS

Também podem ser utilizados como ferramentas de rastreio conforme o protocolo institucional.

RISCO, NÃO EXCLUSÃO

qSOFA

Útil para sinalizar maior risco, mas **não deve ser usado sozinho** para descartar sepse ou decidir quem será avaliado.

Procure deterioração respiratória, hipotensão, alteração aguda do sensório, hipoperfusão, oligúria, necessidade crescente de oxigênio e alterações laboratoriais compatíveis com disfunção orgânica. A sepse é diagnóstico clínico: nenhum biomarcador ou escore isolado confirma ou exclui o quadro.

! **Armadilha:** aguardar qSOFA ≥2 para acionar avaliação pode atrasar o cuidado. A SSC 2026 prefere NEWS/NEWS2, MEWS ou SIRS ao qSOFA como ferramenta única de rastreio hospitalar.

Triagem e biomarcadores: **SSC 2026** .

3. Primeiros minutos: organize ações em paralelo

Sepse e choque séptico são emergências. O fluxo prático deve evitar uma “fila” artificial de tarefas. Enquanto um profissional coleta dados e amostras, outros podem estabilizar ABCDE, preparar acesso, monitorização e terapia já indicada.

Suspeita de infecção + deterioração → **ABCDE e monitorização**

→ **Estratifique choque/probabilidade** → **Culturas + lactato + tratamento indicado**

→ **Reavalie resposta e fonte**

Choque séptico possível, provável ou definido

Antimicrobiano imediatamente, idealmente em até 1 hora do reconhecimento. Ressuscitação hemodinâmica começa sem atraso.

Sepse provável ou definida sem choque

Antimicrobiano imediatamente, idealmente em até 1 hora do reconhecimento.

Sepse apenas possível, sem choque

Investigação rápida e limitada no tempo; se a preocupação com infecção persistir, antimicrobiano em até 3 horas da suspeita inicial.

Baixa probabilidade de infecção, sem choque

Pode-se postergar antimicrobiano enquanto o paciente permanece sob monitorização estreita e a equipe busca diagnóstico alternativo.

Tempo de antimicrobiano: **SSC 2026** .

4. Linha do tempo clínica

Agora	**Reconhecer e estabilizar** ABCDE, monitorização, tempo zero, acesso e comunicação estruturada.	**O quanto antes**	**Culturas e lactato** Hemoculturas idealmente antes do antimicrobiano; medir lactato em sepse possível/provável/ definida ou choque.
≤ 1 h	**Choque ou sepse provável/ definida**	**≤ 3 h**	**Hipoperfusão/choque e sepse possível**

	Antimicrobiano imediato, idealmente dentro da primeira hora.
	Fluido inicial quando indicado; na sepse apenas possível sem choque, concluir investigação rápida e tratar se a preocupação persistir.
≤ 6 h	**Controle de fonte / UTI** Quando houver fonte anatômica que o exija, controle precoce idealmente em até 6 h; UTI também deve ser providenciada sem atraso quando indicada.
Sempre	**Reavaliar** Perfusão, pressão/PAM, consciência, diurese, oxigenação, lactato quando aplicável e tolerância aos fluidos.

Recomendações temporais: **SSC 2026** .

5. Hemoculturas, lactato e investigação

Hemoculturas: antes do antimicrobiano, sem criar atraso evitável

A SSC 2026 recomenda coletar hemoculturas o mais cedo possível e idealmente antes do antimicrobiano. Na prática de enfermagem, qualidade da amostra, identificação correta, horário e técnica asséptica são tão importantes quanto rapidez. Em paciente instável, a logística da coleta não deve se transformar em obstáculo ao tratamento urgente.

O tema específico de hemoculturas deve aprofundar número de conjuntos, volume e prevenção de contaminação; aqui o objetivo é posicionar a coleta no fluxo da sepse.

Lactato: marcador de risco/perfusão, não “teste de sepse”

A SSC 2026 sugere medir lactato em adultos com sepse possível, provável ou definida ou choque séptico. Um valor elevado deve ser interpretado no contexto clínico: pode refletir hipoperfusão, resposta adrenérgica e outros mecanismos. Quando inicialmente elevado ou em choque, a tendência seriada pode ajudar na reavaliação.

Procure a fonte e diagnósticos alternativos

Sepse é diagnóstico clínico. Investigue foco respiratório, urinário, abdominal, pele/partes moles, sistema nervoso central, dispositivos e outras fontes plausíveis. Se a probabilidade de infecção diminuir, reavalie continuamente a necessidade de antimicrobiano e procure causas não infecciosas da deterioração.

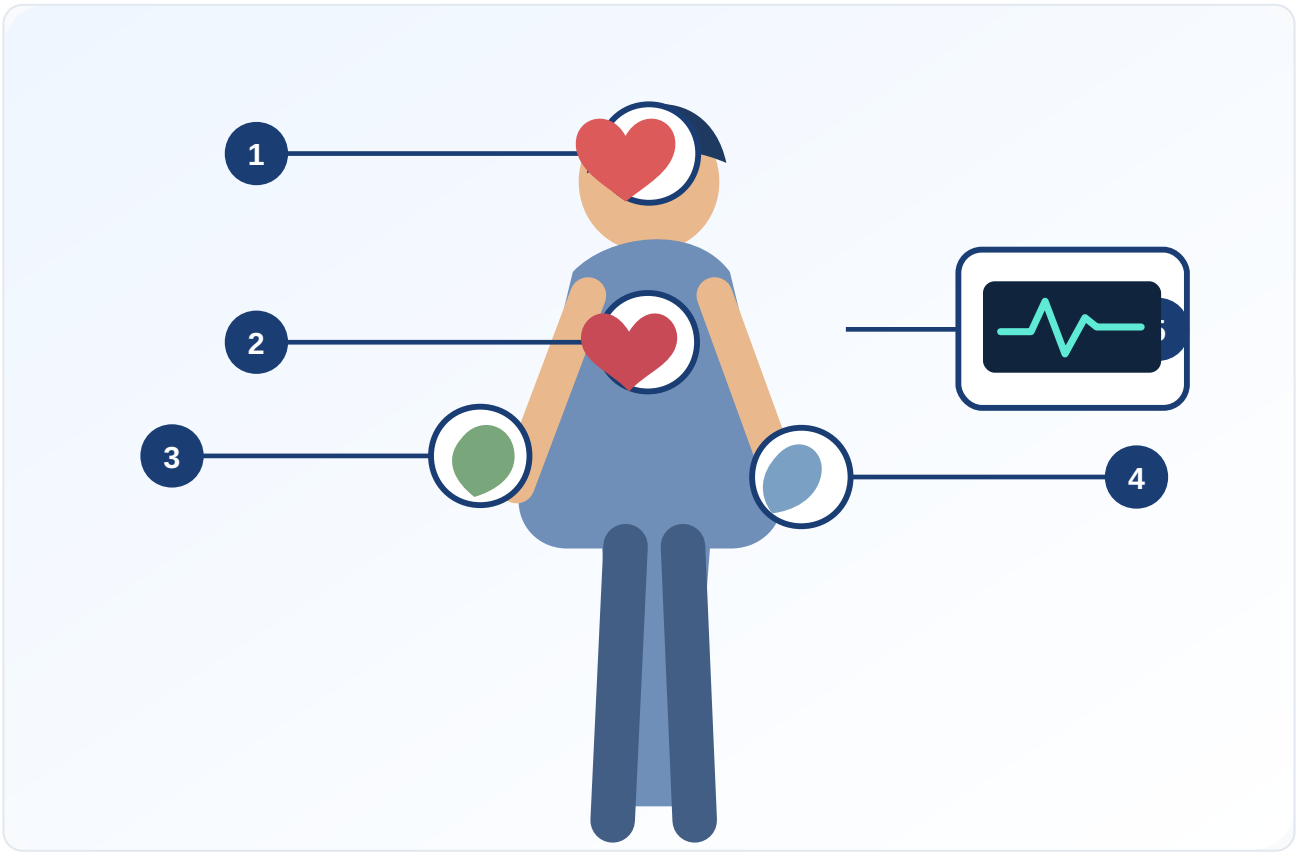
Culturas, lactato e diagnóstico: **SSC 2026** .

6. Ressuscitação hemodinâmica e vasopressor

Para adultos com hipoperfusão induzida por sepse ou choque séptico, a SSC 2026 **sugere pelo menos 30 mL/kg de cristaloide IV nas primeiras 3 horas**, com individualização por características do paciente e reavaliação frequente para evitar sub ou sobrecarga. Cristaloides são primeira linha; na ressuscitação inicial, a diretriz sugere soluções balanceadas sobre salina 0,9% na maioria dos pacientes.

Se a hipotensão persistir, a diretriz sugere vasopressor. Em choque instável, fluido e vasopressor podem ser iniciados concomitantemente caso a caso. Para evitar atraso, o vasopressor pode começar por acesso periférico, com protocolo e vigilância adequados, em vez de aguardar obrigatoriamente um acesso central.

- **Meta inicial de PAM:** 65 mmHg para a maioria dos adultos com choque séptico.
- **Primeira linha:** norepinefrina.
- **Após fluido inicial:** prefira medidas dinâmicas para orientar volume adicional quando disponíveis.



Reavaliação não é um único número. 1 consciência; 2 circulação; 3 perfusão periférica; 4 diurese; 5 pressão/PAM e tendência hemodinâmica.

! **Evite automatismo:** "30 mL/kg" não significa infundir sem observar resposta e tolerância. A própria diretriz enfatiza reavaliação contínua e individualização.

Fluidos, medidas dinâmicas, via periférica e PAM: **SSC 2026** .

7. Reavaliação e controle de fonte

A ressuscitação não termina quando o soro acaba. Depois de cada intervenção, pergunte: **a perfusão melhorou? a pressão/PAM respondeu? o paciente tolerou volume? a necessidade de oxigênio ou vasopressor aumentou?**

Perfusão

- enchimento capilar e temperatura da pele;
- moteamento quando presente;
- estado mental;
- diurese e tendência.

Hemodinâmica

- pressão/PAM e tendência;
- frequência cardíaca;
- resposta a fluido/vasopressor;
- sinais de congestão.

Respiração

- SpO_2 e necessidade de O_2;
- frequência e esforço respiratório;
- ausculta e sinais de edema pulmonar;

Fonte

- existe coleção, obstrução, perfuração ou tecido infectado?
- há dispositivo possivelmente implicado?

- necessidade de suporte maior.

- o paciente precisa de procedimento/ transferência?
- o controle de fonte está sendo organizado?

Quando existe uma fonte anatômica que requer intervenção, a SSC 2026 sugere **controle precoce, idealmente em até 6 horas** do diagnóstico de sepse/choque que exige esse controle.

Reavaliação e controle de fonte: **SSC 2026** .

8. Papel da enfermagem: do reconhecimento ao registro

Reconhecer

- identificar deterioração associada a possível infecção;
- comparar sinais atuais com o basal;
- reconhecer hipoperfusão e choque.

Acionar

- abrir protocolo/código sepse quando aplicável;
- comunicar equipe com dados estruturados;
- registrar o tempo zero.

Executar com segurança

- obter acesso e amostras conforme protocolo;
- administrar terapias prescritas/ protocoladas;
- verificar concentração, bomba e via quando houver vasoativo.

Reavaliar e registrar

- documentar culturas, lactato, antimicrobiano, volume e vasopressor;
- registrar resposta e eventos adversos;
- escalonar deterioração e necessidade de UTI/procedimento.

✓ **Qualidade:** horários confiáveis transformam cuidado em informação auditável. Tempo de reconhecimento, coleta, início do antimicrobiano, fluidos e escalonamento precisam ser rastreáveis.

9. Erros frequentes e como evitá-los

Esperar febre para suspeitar de sepse

Ausência de febre não exclui sepse. Idosos, imunossuprimidos e pacientes muito graves podem apresentar resposta térmica discreta ou hipotermia. Valorize deterioração e disfunção orgânica.

Esperar qSOFA ≥2

qSOFA não deve ser o único gatilho de rastreio. Use a ferramenta institucional e avalie o paciente como um todo.

Atrasar antimicrobiano por tarefas logísticas em choque

No choque, a recomendação é terapia antimicrobiana imediata, idealmente na primeira hora. Organize coleta e tratamento em paralelo.

Infundir fluidos sem reavaliar

Resposta a volume é heterogênea. Documente resposta, sinais de intolerância e necessidade de estratégia adicional.

Não procurar a fonte

Antimicrobiano não substitui drenagem, desobstrução, remoção de foco ou outro controle anatômico quando necessário.

10. Documentação e indicadores

Em sepse, o registro influencia o cuidado imediato e a capacidade do serviço de identificar atrasos e melhorar processos. Não basta anotar que o "protocolo foi realizado": os eventos críticos precisam ser temporalmente rastreáveis e refletir o que de fato aconteceu.

Tempo zero

- hora em que sepse/choque foi reconhecido no fluxo institucional;
- achados que motivaram a ativação;
- quem foi comunicado e quando.

Diagnóstico

- horário das hemoculturas e sítios de coleta;
- lactato inicial e repetição quando indicada;
- foco suspeito e exames prioritários.

Tratamento

- horário de início efetivo do antimicrobiano;
- volume prescrito e volume realmente infundido;
- início, via e titulações de vasopressor quando aplicável.

Resposta

- pressão/PAM, perfusão, consciência e diurese seriadas;
- tolerância a fluidos e eventos adversos;
- escalonamento para UTI, procedimento ou controle de fonte.

Quais indicadores fazem sentido?

Indicadores úteis precisam de definição operacional clara. Exemplos incluem tempo reconhecimento→antimicrobiano nos cenários em que a recomendação temporal se aplica, proporção de culturas coletadas antes do antimicrobiano sem atraso indevido, tempo para lactato, tempo para vasopressor em choque persistente e tempo até controle de fonte quando necessário. O serviço deve definir exatamente qual evento inicia e encerra cada relógio.

Por que registrar o volume realmente infundido?

Prescrição, programação da bomba e volume efetivamente administrado podem divergir por interrupções, transporte, perda de acesso ou mudança clínica. Para interpretar resposta e risco de sobrecarga, o registro precisa refletir o que o paciente recebeu, não apenas o que estava planejado.

11. Caso clínico aplicado

Cenário

Homem de 68 anos chega com dispneia e tosse produtiva há três dias. Está sonolento, FR 30 irpm, PA 86/52 mmHg, FC 118 bpm, SpO_2 89% em ar ambiente, temperatura 37,2 °C. A família relata redução importante da diurese desde a noite anterior.

Leitura inicial: a ausência de febre alta não reduz a gravidade. Há suspeita de foco respiratório associada a hipotensão, alteração do sensório, taquipneia, hipoxemia e oligúria. O conjunto exige avaliação imediata de sepse/choque e estabilização.

1. priorize ABCDE, monitorização e suporte de oxigênio conforme necessidade;
2. acione o fluxo de sepse e registre o momento do reconhecimento;
3. organize acesso, culturas, lactato e demais exames sem criar atraso desnecessário;
4. prepare e administre antimicrobiano no tempo indicado após prescrição/protocolo;
5. inicie ressuscitação prescrita, observando resposta e tolerância;
6. se hipotensão persistir, comunique imediatamente e prepare suporte vasopressor conforme protocolo;
7. reavalie perfusão, diurese, consciência, oxigenação e necessidade de escalonamento.

Pergunta de aprendizagem: qual é o principal erro aqui? Esperar febre, SOFA completo ou resultado de todos os exames antes de reconhecer que o paciente já está instável.

Resumo de bolso

- ✓ Pense em infecção + nova disfunção orgânica, não apenas em febre.
- ✓ NEWS/NEWS2, MEWS ou SIRS são preferidos ao qSOFA como rastreio hospitalar isolado.
- ✓ Culturas: o mais cedo possível e idealmente antes do antimicrobiano.
- ✓ Choque ou sepse provável/definida: antimicrobiano imediato, idealmente ≤1 h.
- ✓ Sepse apenas possível sem choque: investigação rápida; se suspeita persistir, tratar ≤3 h.
- ✓ Hipoperfusão/choque: considerar pelo menos 30 mL/kg de cristaloide nas primeiras 3 h, com individualização.
- ✓ PAM inicial de 65 mmHg para a maioria dos adultos em choque séptico.
- ✓ Reavalie continuamente e organize controle de fonte cedo quando necessário.

Síntese: **SSC 2026** · **Sepsis-3** .

Referências

SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN. International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. Society of Critical Care Medicine / ESICM. Publicada em 23 mar. 2026. SCCM.

SINGER, M. et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA*. 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287. JAMA Network.

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE SEPSE (ILAS). Materiais educacionais e atualização sobre a Surviving Sepsis Campaign. Usar como contexto brasileiro; recomendações terapêuticas nesta página foram ancoradas prioritariamente na diretriz SSC 2026. ILAS.

Revisão de referências: 03 out. 2026. Antes da publicação definitiva, manter monitoramento de atualizações das diretrizes e do protocolo institucional aplicável.

Conteúdo educacional de apoio à enfermagem. Não substitui avaliação clínica, prescrição, protocolo institucional, atribuições profissionais ou julgamento da equipe assistencial.